**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

**Autos: 0807004-76.2022.8.12.0001**
**Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
**Autor:Zuleide de Carvalho Silva Gatto**
**Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**

Vistos...

**Giselle Fernandes Bastos da Silva** ajuizou *ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência* em desfavor de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**.

Em razão de doença diagnosticada –câncer de ovário (CID 10 C56), o médico João Paulo Vendas Villalba, prescreveu o tratamento com indicação do uso do medicamento Nirapartibe 200mg ao dia. Encaminhou a solicitação à parte requerida do fármaco. Todavia, houve negativa por não estar elencado na Diretriz de Utilização (DUT), ou seja, o medicamento não está previsto no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da RN-ANS 465/2021. Contudo, trata-se de procedimento de urgência, que não pode ser negado.

Assim, pediu (f. 8): e) ao final seja julgada procedente a presente ação para o fim de: e.1- confirmar a liminar para fins de fornecimento do tratamento com a medicação ZEJULA (NIRAPARIBE) 100 MG, 02 comprimidos ao dia, por 36 (trinta e seis) meses, CONTINUAMENTE; e.2 – condenar a requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, ao menos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M/FGV desde o evento danoso (RESPOSTA À SOLICITAÇÃO 11-01-2022) até a data do efetivo pagamento; *(sic)*

Anexou documentos (f. 10-26).

Tutela antecipada deferida (f. 28-33).

A parte requerida contestou (f. 49-71) e pleiteou a improcedência dos pedidos, ante a ausência de previsão contratual, falta de previsão do medicamento na Dut 64 da RN 465/2021 da ANS, e existência de outros fármacos para o tratamento, além de não se tratar de caso de urgência/emergência.

Justapôs documentos (f. 72-485).

Audiência de conciliação infrutífera (f. 491).

Réplica (f. 494-507) com a juntada de novos documentos (f. 508-511).





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Agravo de instrumento mantendo a concessão da tutela antecipada (f. 520-540).

Na decisão de saneamento (f. 554-556), o juízo fixou os pontos controvertidos, delimitou o ônus da prova e deferiu a prova pericial.

Sobreveio o laudo pericial (f. 962-997), com manifestações das partes (f. 1003-1009 e 1017-1021), e homologação judicial (f. 1032).

As partes apresentaram alegações finais escritas (f. 1035-1044 e 1045-1047).

**É o relatório. Passo a decidir.**

Para julgamento da causa, o juízo delimitou os pontos controvertidos (f. 554-556):

> **Fato 1**: controvertem as partes acerca da imprescindibilidade do tratamento quimioterápico com a medicação indicada pelo médico assistente, e se a patologia que acomete a parte requerente pode ser tratada com outros fármacos igualmente eficazes e acobertados pelo plano de saúde.
>
> Ônus da prova: diante da verossimilhança das alegações da parte requerente, sobretudo por causa do laudo médico, e por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova deve ser invertido, de modo que cabe à parte requerida comprovar que o medicamento indicado pode ser substituído por outro similar igualmente eficaz, conforme orientações do médico especialista (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6, VIII).
>
> Prova cabível: documental suplementar e prova técnica simplificada, consistente na oitiva de profissional especialista na área médica acerca da enfermidade da parte requerente.
>
> **Fato 2**: controvertem-se se o tratamento quimioterápico indicado é de urgência, ou eletivo, e se gera risco de vida/morte imediato à parte requerente, enquadrando-se nas hipóteses que excepcionam as regras da cobertura.
>
> Ônus da prova: cabe à parte requerida comprovar que a parte requerente não necessita do procedimento como forma de preservação da sua vida ou prevenção contra lesões irreparáveis à saúde (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6, VIII).
>
> Provas admitidas: documental suplementar e prova técnica simplificada, consistente na oitiva de profissional especialista na área médica acerca da enfermidade da parte requerente.
>
> **Fato 3.** compete à parte requerente comprovar a repercussão negativa dos fatos na esfera dos seus direitos da personalidade e a extensão dos danos de ordem moral que afirma ter suportado (CPC, art. 373, I).
>
> Provas admitidas: depoimento pessoal, testemunhal e documental suplementar.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Restou incontroverso que a parte requerente é beneficiária do plano de saúde gerido pela parte requerida, encontrando-se acometida de câncer de ovário, consoante relatório médico (f. 22):

> A PACIENTE ACIMA É PORTADORA DE CANCER DE OVARIO AVANÇADO OPERADO EM 05/2021.

Em razão da doença diagnosticada, o médico especialista indicou o tratamento de manutenção com a Niraparibe 200mg ao dia (f. 136-7):

> APÓS A CIRURGIA DE CITORREDUÇÃO, OS EXAMES MOSTRAVAM PERSISTENCIA DE ASCITE E CA 125 ELEVADO, COM EVIDENCIAS DE LINFONODOMEGALIAS.
> REALIZOU TRATAMENTO ADJUVANTE COM 6 CICLOS DE QUIMIOTERAPIA COM RESOLUÇÃO DA ASCITE, LINFONODOMEGALIAS E NORMALIZAÇÃO DO CA 125.
> COMO TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO, EXISTE INDICAÇÃO DE NIRAPARIBE 200MG AO DIA.
> O TRATAMENTO TEM EMBASAMENTO CIENTIFICO NO ESTUDO PIVOTAL - PRIMA TRIAL (ANEXO).
> O ESTUDO MOSTRA REDUÇÃO DO RISCO DE RECORRENCIA EM 57% (HR 0,43), COM SIGNIFICANCIA ESTATISTICA, NOS PACIENTES COM DEFICIENCIA DE RECOMBINAÇÃO HOMOLOGA (PACIENTE EM QUESTAO).
> O TRATAMENTO E INDICADO POR 36 MESES, CONFORME PROTOCOLO DO ESTUDO.
> SEGUE BULA DO MEDICAMENTO E ESTUDO (PRIMA TRIAL).

A parte requerida negou o fornecimento da medicação, ao pretexto de ausência de previsão contratual, falta de previsão do medicamento na Dut 64 da RN 465/2021 da ANS, e existência de outros fármacos para o tratamento, além de não se tratar de caso de urgência/emergência.

Pois bem.

O procedimento está prescrito pelo médico responsável para o tratamento da patologia que acomete a parte requerente. Logo, incabível a negativa de disponibilização do tratamento, notadamente porque na solicitação médica havia indicação da **urgência no fornecimento da medicação em decorrência do estado avançado da doença.**

A perícia confirmou o diagnóstico da parte requerente (f. 972) e a gravidade do seu estado de saúde (f. 973):



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

2) Qual(is) a(s) enfermidade(s)da paciente? Favor declinar C.I.D.(s).

**Resposta: Tumor Maligno Ovário; CID C56.**

5) Qual a gravidade dessa doença?

**Resposta: Evolução com piora progressiva quando não recebe tratamento.**

6) Cuida-se de doença crônica ou há previsão de cura?

**Resposta: Situação em análise é passível de tratamento com melhora.**

Apesar do perito afirmar que o tratamento com a medicação indicada, não se enquadra na definição de urgência/emergência, o que, em tese, afastaria a obrigatoriedade da parte requerida de autorizar o tratamento, havia comprovação explícita da urgência do tratamento, conforme relato do médico da parte requerente (f. 22).

Além disso, as conclusões do perito, conquanto sejam sempre muito lúcidas, não vinculam o juízo, considerando-se que o médico da parte requerente foi incisivo quanto à necessidade de uso do medicamento (f. 1017-1021):

> CPC, Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
>
> (...). 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial em virtude do princípio da livre convicção, caso as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito. 6. Agravo Interno não provido. *(STJ; AgInt-AREsp 2.176.843; Proc. 2022/0230601-6; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)*
>
> **APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.** Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Paciente acometida de câncer de ovário. Pretensão de cobertura para fornecimento de medicamentos (Niraparibe e Olaparibe). Negativa de fornecimento pela operadora de plano de saúde que contraria o disposto nos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.696/98 e Súmulas nºs 102 e 95 do TJSP. Prescrição off label. Irrelevância. Paciente submetida previamente a quimioterapia e cirurgia. Cobertura devida. Precedentes. Recurso desprovido. *(TJSP; AC 1087280-17.2022.8.26.0100; Ac. 17730487; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 27/03/2024; DJESP*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

*03/04/2024; Pág. 1756)*

O parecer do assistente técnico da parte requerida não trouxe maiores esclarecimentos, notadamente porque reproduziu o histórico da paciente, concordando com o laudo médico judicial quanto à inexistência de urgência do caso (f. 1010-1016).

Cabe ao profissional de saúde e não ao plano de saúde definir a urgência do caso, pois a parte requerente já havia realizado procedimento cirúrgico. Aliás, a escolha do tratamento mais indicado ao caso clínico da paciente cabe ao médico especialista, consoante as recentes alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022.

Quanto ao **dano moral**, é possível observar que, em 11/1/2022, a parte requerida negou o pedido de fornecimento da medicação; em 24/2/2022, a parte requerente ajuizou a presente demanda e, em 4/3/22, concedeu-se a tutela antecipada.

Conquanto a responsabilidade civil seja objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, o simples inadimplemento de obrigação contratual não configura dano moral *in re ipsa*. Isso porque estamos diante de discussão contratual com enfoques diferentes e argumentos que podem alcançar os dois lados. Além disso, a parte requerida atendeu a tutela antecipada sem maiores percalços, mesmo porque, não se tem notícia de negativa administrativa da medicação tenha agravado o estado de saúde de parte requerente:

> (...) **4. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. Para ser reconhecido, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.** 5. A situação enfrentada pela segurada, com a rescisão unilateral do plano de saúde, por si só, não se mostrou suficiente para configurar a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente porque não há nos autos qualquer informação de que a tutela de urgência deferida tenha sido descumprida, tampouco, que a negativa da seguradora tenha causado prejuízo ao estado de saúde da autora, ou agravado sua situação. **5.1. O simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde não enseja a obrigação de indenizar o dano moral.** 6. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do Código de Processo Civil. 6.1. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir à requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação à autora. *(TJDF; APC 07082.73-40.2023.8.07.0004; 183.7609; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 04/04/2024; Publ. PJe 10/04/2024)*

***Diante do exposto***, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a) Julgo procedente o pedido para condenar a parte requerida na obrigação de fornecer a medicação indicada pelo médico especialista e durante o período da prescrição médica (f. 1022-1023), ratificando-se a tutela antecipada outrora concedida; e,

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, atento às diretrizes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 11% (onze porcento) sobre o valor pago pela parte requerida pela medicação fornecida entre o cumprimento da liminar até o trânsito em julgado da demanda, em especial pela ocorrência de perícia.

b) Julgo improcedente o pedido de R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.

Sucumbente, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios de 11% (onze porcento) sobre o valor que a parte requerida deixou de ser condenada em danos morais, com atualização monetária pelo IPCA do ajuizamento da demanda, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela ocorrência de perícia.

Custas e despesas (perícia) em 50% para cada parte, considerando-se um pedido procedente e outro improcedente.

Suspendo os pagamentos de honorários, custas e despesas (perícia) em relação à parte requerente por ser beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º - f. 30).

Expeça-se guia de levantamento em favor do perito, caso não tenha levantado os honorários periciais.

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

**Marcus Vinícius de Oliveira Elias**
**Juiz de Direito**





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 24/07/2025 às 14:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807004-76.2022.8.12.0001 e código Dcfkld5f.